

Catatonie induite par le sevrage d'un traitement psychotrope

🧑 La catatonie est un syndrome complexe caractérisé par des perturbations majeures de la motricité, se manifestant par :

- 🔊 une absence d'activité motrice et de communication totale et permanente, ou alternant avec des états d'agitation sans but apparent
 - 🔊 des postures figées, spontanées ou après tentative de mobilisation par autrui
 - 🔊 des mouvements répétitifs ou bizarres
 - 🔊 des mouvements ou paroles répétant ceux d'autres personnes (échopraxie, écholalie)
- Pour plus de détails cf <https://www.catatonia.fr/quest-ce-que-la-catatonie>

🧑 Même si ce syndrome a été traditionnellement associé au diagnostic de schizophrénie, il est actuellement très clairement démontré qu'il n'a aucune spécificité diagnostique.

- 🔊 l'apparition d'une catatonie peut être liée à de multiples causes psychiatriques et non-psychiatriques.
- 🔊 éliminer une cause somatique autre que psychiatrique est une priorité absolue
- 🔊 les étiologies neurologiques et/ou infectieuses sont en général rapidement évoquées
- 🔊 il faut aussi systématiquement penser à une catatonie induite par un sevrage médicamenteux

💊 Les médicaments psychotropes dont l'arrêt brutal peut induire un syndrome catatonique sont essentiellement :

- 🔊 les benzodiazépines et molécules apparentées (zolpidem, zopiclone)
- 🔊 la clozapine

🧑 Le syndrome catatonique

- 🔊 apparaît dans les jours suivant l'arrêt d'un traitement chronique
- 🔊 peut être observé même quand le traitement est prescrit à doses faibles à modérées
- 🔊 ne doit pas être confondu avec une rechute du trouble ayant motivé la prescription
- 🔊 un sevrage concomitant d'alcool ou de cannabis peut avoir un effet aggravant

🧑 L'apparition du syndrome catatonique est liée à plusieurs mécanismes physiopathologiques :

- 🔊 quel que soit le médicament, une hypoactivité de la transmission GABAergique est probablement impliquée
- 🔊 le sevrage en clozapine entraîne une levée de l'effet anticholinergique très puissant de cette molécule : le rebond cholinergique entraînant une hypotransmission dopaminergique joue probablement un rôle central.

💡 Concernant la prise en charge :

- 🔊 la stratégie la plus efficace est la reprise du médicament arrêté, si possible
- 🔊 la reprise des benzodiazépines est à prioriser pour les sevrages induits par leur arrêt
- 🔊 les ECT sont efficaces quel que soit le médicament en cause
- 🔊 pour le sevrage en clozapine
 - (i) s'il n'est pas possible de reprendre la clozapine, un traitement anticholinergique doit être initié rapidement, à débiter souvent sous forme injectable (par ex biperidone)
 - (ii) on peut y associer de l'olanzapine pour ses effets anticholinergiques et antipsychotiques
 - (iii) les benzodiazépines sont peu efficaces

⚠ La meilleure prévention d'une catatonie de sevrage repose sur un arrêt très progressif des benzodiazépines ou de la clozapine. Les usagers doivent être informés de ce risque, s'ils décident d'arrêter leur traitement sans en informer le prescripteur.

Références

<https://doi.org/10.1177/02698811231158232>

<https://doi.org/10.2165/00023210-200519120-00006>

